

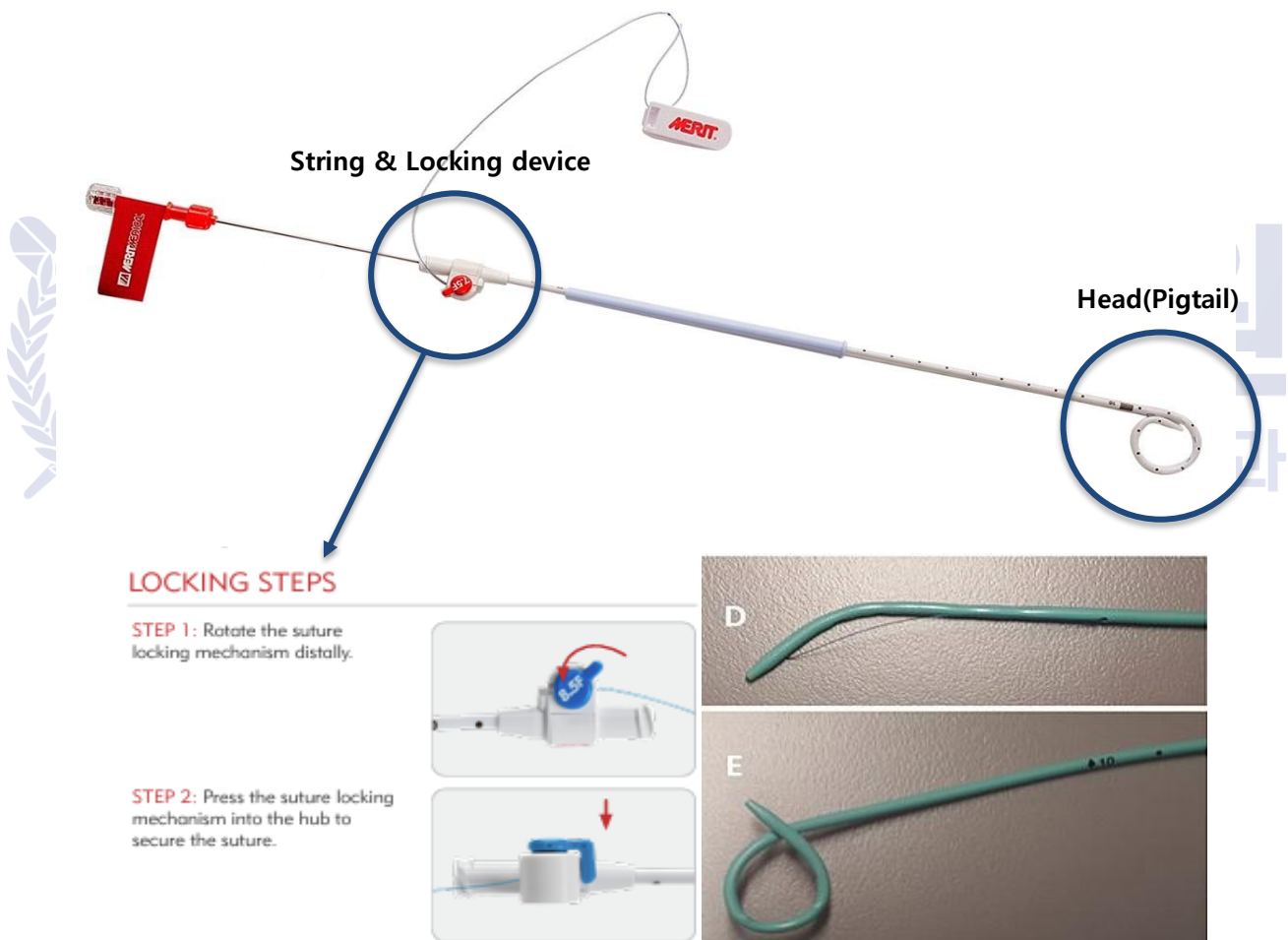
PCD 경피적 카테터 배액술

(Percutaneous Catheter Drainage)

복수, 흉수 등 국소적으로 조직이나 장기 내부 또는 제한된 공간 내에 발생한 농양이나 체액들을 지속적으로 배액하기 위하여 체내에 카테터(Catheter)를 넣어 내용물을 배출시키는 시술

배액관은 사용함에 따라 관 기능이 떨어지고 막히게 되어 주기적인 교체가 필요함

배액하고자 하는 액체의 점도에 따라 배액관의 크기 결정 (1Fr = 3mm)



적응증

복강 내 복수(Ascites)

흉막삼출(Pleural effusion); 여러가지 원인(폐 염증, 농흉, 악성종양 또는 외상)에 의해 장막흉막과 벽측 흉막사이에 물이나 피가 고였을 때

조직이나 장기 내부 또는 제한된 공간 내에 액체가 발생한 것

간농양(Liver abscess), 기타 수술 후의 fluid collection 등 non-vascular 에 이용되는 모든 튜브 배액



시술 전 확인사항

시술동의서 작성 유무

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

약물 알러지 확인 - 전처치 여부 결정

시술 부위 확인-좌우

시술재료

PTBD Package, suture set

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 cover

베타딘 소독액, 거즈

N/S 500mL(irrigation 용), 2%리도카인

26G long needle, 11 번 blade, nylon 3-0

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)

10cc Syringe 1 개 (셀라인 1)

Micro puncture set

PRN: 18G chiba needle(COOK) or 21G SET

Terumo guide wire (0.035" angle 180cm)

Drainage catheter(RESOLVE), PRN: Dilator 8~14Fr

(배액량 또는 배액양상에 따라 적절한 크기의 cath./Dilator 준비 / ex. LUNG PCD: 10.2Fr)

Bile bag, 3-way 1 개, Drain-lok or 슈퍼포아 4 호

Glove: Dr.정 6.5 / Dr.권 7.0 / Dr.최 7.5

시술방법

- ① 초음파 유도 하에 천자할 곳을 확인하고 needle 로 천자
- ② g/w 를 이용하여 dilator 와 알맞은 크기의 drainage cath.를 삽입 후 Pigtail distal loop 말리게 고정
- ③ fluoroscopy 시행 후 배액관을 피부에 suture 하여 고정시킨 다음 bile bag 연결 후 시술 종료

간호업무지침

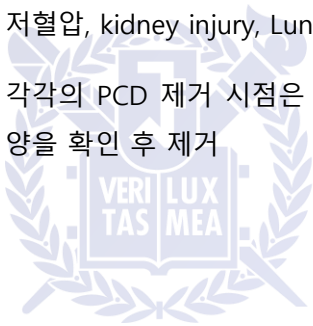
BP, SPO2 monitoring, 필요시 산소공급 (N-P 3L/min)

Lung PCD 의 경우 기흉 가능성이 있어, 호흡곤란 증상 및 SPO2 확인 필수

배액관 교체시 기존 카테터는 Bile bag 과 분리 후 cap 으로 막아 준비

시술 후 Ascites, Pleural effusion 의 경우 급격히 많은 양을 배액하거나, 하루에 너무 많은 양을 배액할 경우 저혈압, kidney injury, Lung collapse 등 합병증 발생할 수 있어 배액량 확인

각각의 PCD 제거 시점은 상태에 따라 다르지만, 대부분 충분히 배액이 되었을 경우 CT or X-ray 통해 남은 양을 확인 후 제거



서울88의원
영상의학과 · 심장혈관외과

PCN 경피적 신루설치술

(Percutaneous Nephrostomy)

신장에서 걸러진 소변이 여러가지 원인에 의해 자연적으로 배설되지 못하는 경우 소변의 배출통로가 막히면 통증, 감염이 발생하고 심할 경우 신부전에 이를 수 있으며, 이를 예방하고 치료하기 위해 신우에서 직접 카테터(Catheter)를 삽입해 소변을 제거하는 시술

적응증

요로폐쇄를 해결하는 안전하고 효율적인 초기 치료법

Hydronephrosis; 결석, 종양, Stricture 등으로 협착이 온 경우 또는 감염

수술 후 Urine leakage 있는 경우 소변이 계속 흘러가면 Healing 되지 않으므로 일시적으로 소변을 밖으로 나가게 하기 위한 통로로 이용

시술 전 확인사항

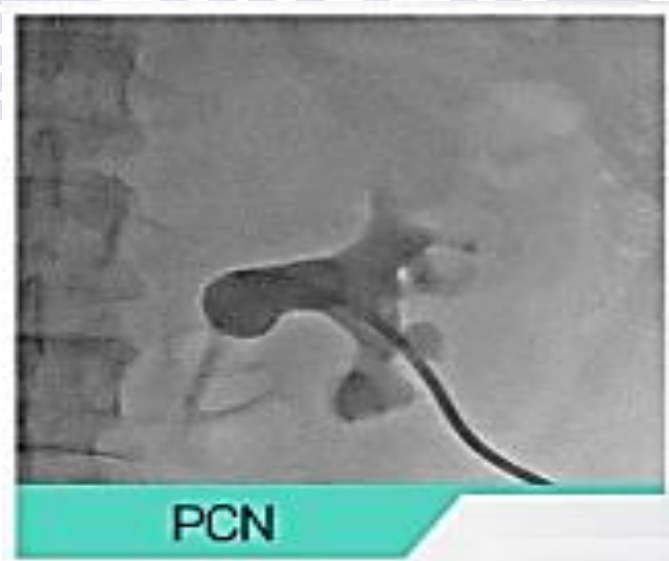
시술동의서 작성 유무

최소 2 시간 금식 (경구 투약 제외)

상의속옷 탈의 및 환의로 환복, 장신구 제거

약물 알러지 확인 - 전처치 여부 결정

시술 부위 확인-좌우



시술재료

Drainage Package, suture set

파미레이 300 50ml

c-arm 용 angio cover 50×50, 초음파 cover

26G long needle, 11 번 blade, nylon 3-0

베타딘 소독액, 거즈

10cc lock Syringe 1 개 (리도카인 1)

N/S 500mL(irrigation 용), 2%리도카인

10cc Syringe 2 개 (셀라인 1 조영제 1)

Micro puncture set

PRN: 21G SET; 21G chiba needle & yellow sheath(MAK-NV) & hair wire

Terumo guide wire (0.035" angle 180cm)

Drainage catheter 8.5Fr (RESOLVE/COOK)

PRN: Dilator 8~14Fr

Bile bag, 3-way 1 개, 슈퍼포아 4 호

Glove: Dr.정 6.5 / Dr.권 7.0 / Dr.최 7.5

시술방법

- ① 초음파 유도 하에 천자할 곳(신장의 lower pole posterior calyx)을 확인하고 needle 로 천자
- ② g/w 를 이용하여 dilator 와 알맞은 크기의 drainage cath.를 삽입
- ③ 조영제를 이용하여 Tubography 시행 후 Pigtail distal loop 말리게 고정
- ④ 주사기로 regurgitation 하여 Urine 확인
- ⑤ 배액관을 피부에 suture 하여 고정시킨 다음 bile bag 을 연결 후 시술 종료

간호업무지침

BP, SPO2 monitoring, 필요시 산소공급 (N-P 3L/min)

자세: Prone (단, 신장이식 환자의 경우 Supine)

배액관 교체시 기존 카테터는 Bile bag 과 분리 후 cap 으로 막아 준비

장기간 PCN 유지하는 경우 특별한 증상이 없더라도 3 개월마다 교체

